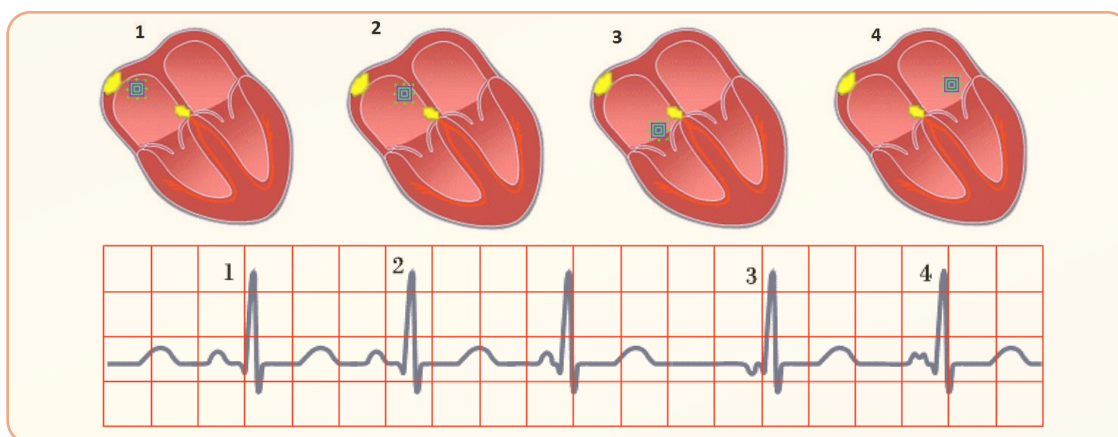


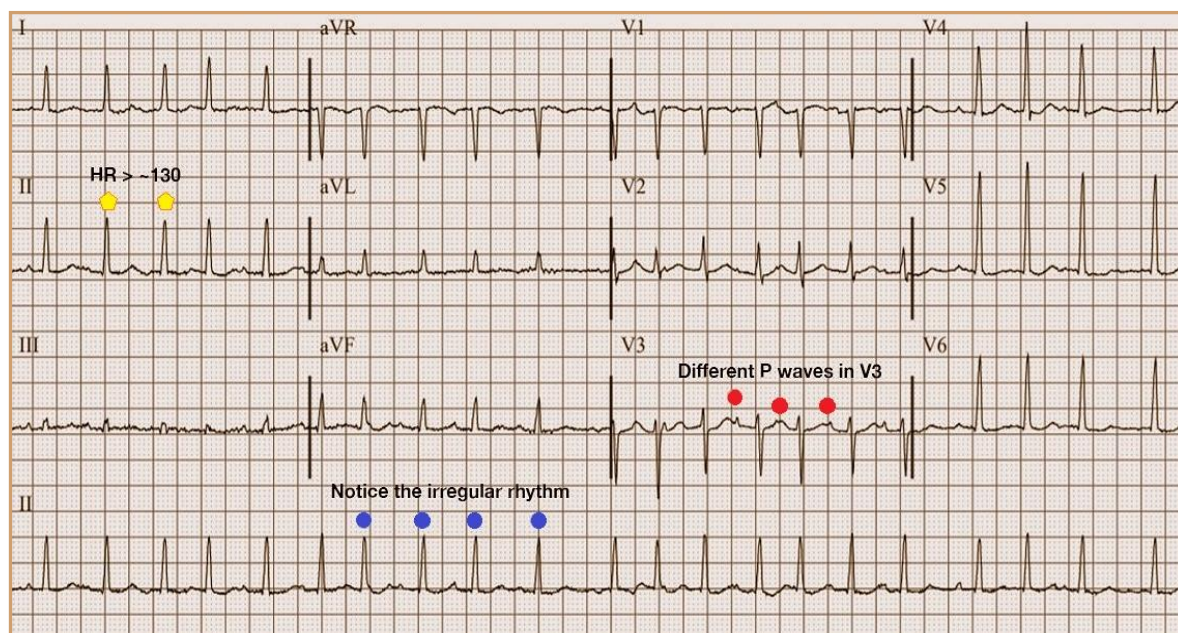
Πολυεστιακή Κολπική Ταχυκαρδία – Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)

Στην ΠΕΚΤ (MAT) ο καρδιακός ρυθμός κυμαίνεται μεταξύ 100-160 παλμοί /λεπτό· (σε περιπτώσεις που ο καρδιακός ρυθμός είναι μικρότερος από 100 bpm τότε χρησιμοποιείται ο όρος «πλανώμενος βηματοδότης, με βηματοδότη μετακινούμενο από το φλεβόκομβο στο κολπικό μυοκάρδιο και στον κολποκοιλιακό κόμβο και πάλι πίσω προς το φλεβόκομβο).

- Στο ΗΚΓ εμφανίζονται, χαρακτηριστικά, τουλάχιστον τρία διαφορετικής μορφολογίας επάρματα P, από τουλάχιστον τρία διαφορετικά έκτοπα κέντρα. Έτσι:
 - ✓ Το έπαρμα P είναι φυσιολογικό όταν βηματοδότης είναι ο φλεβόκομβος. Όταν όμως ο βηματοδότης της καρδιάς βρίσκεται στον κολποκοιλιακό κόμβο τότε το έπαρμα P εμφανίζεται αρνητικό στις κατώτερες απαγωγές II, III, aVF και θετικό στην aVR.
 - ✓ Μπορεί να εμφανιστούν επίσης μεταβλητά διαστήματα PP, PR και RR.



- Επειδή ο ρυθμός είναι ακανόνιστος, μια Πολυεστιακή Κολπική Ταχυκαρδία (ΠΕΚΤ) μπορεί να εκληφθεί ως κολπικός πτερυγισμός (*A-Flu*) ή ως κολπική μαρμαρυγή (*A-Fib*).
- Εμφανίζεται συνήθως σε ηλικιωμένα άτομα με μη αντιρροπούμενη ΧΑΠ (60-85% των περιπτώσεων), ΣΝ, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, τοξικότητα από αμινοφυλλίνη, διγοξίνη ή ισοπροτερενόλη, οξύ ρευματικό πυρετό ή άλλη βαλβιδική νόσο της καρδιάς, υποκαλιαιμία, υπομαγνησισαιμία, πνευμονική εμβολή, πνευμονία, μετεγχειρητικά, κ.ά.
- Η εμφάνιση ΠΕΚΤ, όταν συνυπάρχει σοβαρό υποκείμενο νόσημα, δεν προδικάζει καλή πρόγνωση, αφού εμφανίζει υψηλή θνησιμότητα (Mort > 45%) από την υποκείμενη νόσο. Συχνά είναι ασυμπτωματική, αλλά μπορεί να εμφανίζεται με έντονη δυσφορία, αίσθημα παλμών, δύσπνοια, προκάρδιο άλγος, κεφαλαλγία με φωταγνίες ή συγκοπτικό επεισόδιο.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η αρχική προσέγγιση της ΠΕΚΤ απαιτεί να αναγνωρίσουμε και να ελέγξουμε ή/και να θεραπεύσουμε την υποκείμενη νοσολογική οντότητα η οποία πιθανότατα ευθύνεται για την εμφάνιση της ταχυαρρυθμίας (π.χ. *θεραπεία υποκαλιαιμίας ή παρόξυνσης ΧΑΠ ή να διακόψουμε τη χορήγηση θεοφυλλίνης που αποτελεί συνήθη αγωγή σε ασθενείς με ΧΑΠ*).
2. Τοποθετούμε ευρεία φλεβική γραμμή και χορηγούμε 2 gr **θεικό Μαγνήσιο ($MgSO_4$)** εντός 3-5 λεπτών (δηλαδή 1 amp. 2 gr $MgSO_4$ μαζί με 50 ml N/S), σε bolus iv έγχυση.
3. Κατόπιν χορηγούμε Μαγνήσιο σε συνεχή έγχυση (iv). Τοποθετούμε δηλαδή 500 ml N/S με 6 gr (ήτοι 3 amp.) $MgSO_4$ και το χορηγούμε εντός 6 ωρών (δηλαδή με ρυθμό 1 g/h). Εκτός από τις αντιαρρυθμικές δράσεις του, το Μαγνήσιο διαστέλλει τις πνευμονικές αρτηρίες, ενέργεια που βοηθάει, κρίσιμα, σε ασθενείς με ΠΕΚΤ λόγω ύπαρξης ΧΑΠ.
4. Βασικό μέλημά μας, λοιπόν, η διόρθωση της υπομαγνησιαιμίας και της υποκαλιαιμίας εφόσον υπάρχουν. Εάν όμως υφίστανται αμφοτέρως οι διαταραχές, πρώτα διορθώνουμε το έλλειμα Μαγνησίου και κατόπιν προχωρούμε στη διόρθωση του ελλείμματος Καλίου (χορηγούνται 2 amp. KCl, εντός 250 ml NaCl 0,9% ή D₅W, σε διάστημα 60 λεπτών). Η συγκέντρωση K^+ στον ορό πρέπει να διατηρείται σε επίπεδα άνω των 4 mEq/L για την αύξηση της σταθερότητας των κυτταρικών μεμβρανών του μυοκαρδίου.
5. Αν η μέτρηση των επιπέδων Μαγνησίου (Mg^{++}) και Καλίου (K^+) δεν είναι εφικτή στο ΤΕΠ, τότε – *κι εφόσον ο ασθενής δεν πάσχει από σοβαρή ΧΑΠ* – χορηγούμε ενδοφλεβίως **Μετοπρολόλη** 2-5 mg iv-bolus, εντός δύο (2) λεπτών. Επαναλαμβάνουμε τη χορήγηση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, μετά από 15-20 λεπτά, μέχρι το μέγιστο των 3 δόσεων (max: 15 mg). Η Μετοπρολόλη (εκλεκτικός B_1 αναστολέας) δύναται να χορηγηθεί και per os ($\frac{1}{4}$ tab. Lopresor 100 mg), ενώ έχει αναφερθεί σε διάφορες κλινικές σειρές ότι μετατρέπει γρήγορα την ΠΕΚΤ σε φλεβοκομβικό ρυθμό στο 70-95% των περιπτώσεων.
6. Εναλλακτικά, (στους ασθενείς με ΧΑΠ) χορηγούμε ενδοφλεβίως **Βεραπαμίλη** 5-10 mg (δηλαδή αναρροφούμε 1-2 amp. Isoptin των 5 mg μαζί με 10-15 ml N/S και χορηγούμε βραδέως ενδοφλεβίως εντός 1-2 λεπτών). Εάν χρειαστεί επαναλαμβάνουμε τη χορήγηση Βεραπαμίλης (η οποία έχει ήπιες βρογχοδιασταλτικές ιδιότητες) σε δόση 0,15 mg/kg ΒΣ (3 amp. Isoptin σε 250 ml NaCl 0,9%, εντός 15 λεπτών). Για να αποφύγουμε ή/και για να αναστρέψουμε την υπόταση ή τη βραδυκαρδία που προκαλείται από τη Βεραπαμίλη, χορηγούμε 3-5 ml **Χλωριούχο Ασβέστιο 10%** εντός 100 ml N/S, σε έγχυση 5-10 λεπτών.
7. Η ηλεκτρική ανάταξη σε ΠΕΚΤ είναι αναποτελεσματική και δεν πρέπει να επιχειρείται.

